



CLÍNICA
DA FACE

CONSULTA PÓS-OPERATÓRIA 22/12/2014

NOTA DE ALTA

DATA 19 - 12 - 2014

DOENTE JOSÉ MARIA ÁVILA MELO SERAFIM COSTA

HOSPITAL

BRITISH HOSPITAL LX

DATA DA CIRURGIA

17 DEZ. 2014

DATA INTERNAMENTO

17/12/2014

DIAGNÓSTICO

Doente de 27 anos que apresentava uma grave disfunção respiratória noturna, traduzida numa síndrome de apneia obstrutiva do sono, associada a deformidade dento-facial, devida a acentuada hipoplasia condiliana e consequente micrognatismo, encontrando-se a mandíbula em posição muito retruída, que condicionava uma evidente diminuição do espaço respiratório faríngeo. (vide relatórios associados).

Apresentava ainda:

- Disfunção álgica das articulações têmporo-mandibulares.
- classe II esquelética, com perfil convexo muito marcado
- Ângulo do plano oclusal superior muito acentuado em acentuada posição de rotação horária (ver TAC)
-

O doente foi preparado com aparatologia ortodôntica fixa para o tratamento cirúrgico ortognático.

CIRURGIA

Sob anestesia geral, procedemos a:

- Osteotomia de LeFort I para reposicionamento tridimensional do maxilar superior. O maxilar foi fixado com placas e parafusos de titânio.
- Osteotomias sagitais dos ramos ascendentes da mandíbula com preservação do pedículo vascular-nervoso. Fixação rígida bilateral com uma placa de BSSO e 4 parafusos.
- Mentoplastia de avanço. Fixação com placa de titânio especial de mento e 4 parafusos
- Suturas com pontos reabsorvíveis.
- A intervenção e o período pós-operatório imediato decorreram sem complicações.
- Foi fornecido ao doente orientação pós operatória terapêutica e alimentar

PÓS-OPERATÓRIO

A intervenção e o período pós-operatório decorreram sem complicações.

Foi fornecido ao doente orientação pós-operatória terapêutica e alimentar.

Foi medicado com antibióticos, anti-inflamatórios esteróides e não esteróides, analgésicos e aplicação de frio local.

Foi reinstituída precocemente a terapêutica ortodôntica.

RESUMO

Doente jovem com apneia grave do sono, que foi sujeito a cirurgia ortognática bimaxilar complementada com mentoplastia com osteotomias. O maxilar superior foi reposicionado para se poderem corrigir os problemas verticais, transversais e sagitais e se poder avançar a mandíbula e criar espaço respiratório superior. Com a mesma finalidade foi avançado o mento, com osteotomias supra genianas, tendo em vista traccionar os músculos génio-glosso e génio-hiódeu. Intervenção cirúrgica de elevada dificuldade técnica. Internamento de 48 horas.

A. Matos da Fonseca
Cirurgia Maxilo-Facial

Relatório ao abrigo do Artigo 98, § 1 e 2 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos.

Relatório assinado digitalmente. Esta é uma impressão do original que está disponível para consulta, nos termos da Lei.

Complexo Hospitalar das Torres de Lisboa
Telefone +351 21 721 09 00 - +351 93 721 09 00

Rua Tomás da Fonseca, Torre F, Piso 1 1600-209
<http://www.clinicadaface.com>

Lisboa – Portugal
clinica@clinicadaface.com